6.腹腔间隔室综合征：通过膀胱内测腹内压≥**20**mmHg 可**诊断**为 ACS，若≥**25**mmHg 为开腹**手术**的指征

SIRS在肺部表现 胰腺炎导致大量渗出→有效循环血容量↓

肾前性肾衰竭在临床常见
eg.心衰、胰腺炎、肝硬化
都可导致有效循环血量↓

7.ARDS、肾功能不全、左侧门静脉高压（门静脉或脾静脉血栓形成）等

注意：肺血栓栓塞症的下肢深静脉、肝硬化或胰腺炎的门静脉和脾静脉、肾病综合征如膜性肾病的肾静脉、PNH 的肝静脉血栓形成

可能可能最可能：**胆石症/饮酒/暴饮暴食/ERCP 等病史，突发上腹偏左痛、向左肩及腰背放射、呕吐不减轻、弯腰抱膝减轻。若休克、血性腹水、Cullen/G-T 征等提示重症胰腺炎**

表 4-20-1　AP 多器官功能障碍的症状、体征及相应的病理生理改变

症状及体征	病理生理改变
低血压、休克	大量炎性渗出，严重炎症反应及感染
呼吸困难	肺间质水肿、成人呼吸窘迫综合征、胸腔积液，严重肠麻痹及腹膜炎
腹痛、腹胀、呕吐、全腹膨隆、张力较高，广泛压痛及反跳痛，移动性浊音阳性，肠鸣音少而弱，甚至消失	肠麻痹、腹膜炎、腹腔间隔室综合征
少尿、无尿	休克、肾功能不全
黄疸加深	胆总管下端梗阻，肝损伤或肝衰竭
格雷-特纳（Grey-Turner）征，卡伦（Cullen）征	胰腺出血坏死
体温持续升高或不降	严重炎症反应及感染
意识障碍，精神失常	胰性脑病
上消化道出血	应激性溃疡，左侧门静脉高压
猝死	严重心律失常

五、检查

（一）淀粉酶和脂肪酶

血淀粉酶/脂肪酶 （定性不定量） ttsx	诊断急性胰腺炎的**首选**	题目中没查必先查
	诊断水肿型急性胰腺炎的最佳	必升高
	与诊断的**准确率相关**	超过正常值 3 倍（**＞500**U/dl）诊断准确率高，越高诊断越正确
	与病情**严重程度无关** 不是诊断重症胰腺炎的最佳	**重症者可升高、正常、下降**
腹水淀粉酶/脂肪酶	与病情**严重程度相关** 诊断重症胰腺炎的最佳	必升高，越高病情越严重 不首选原因:腹穿是有创操作

病情越严重→腺泡细胞坏死越多→越多的淀粉酶被释放入腹水→腹水淀粉酶↑

《诊断学》：

①血淀粉酶在起病后 2-12 小时开始升高、24 小时达高峰、持续 3-5 天

②血脂肪酶在起病后 24-72 小时开始升高、持续 7-10 天，特异性优于血淀粉酶，适合发病 **1 周**血淀粉酶已恢复者

③尿淀粉酶在起病后 24 小时开始升高、持续 1-2 周，受肾功能影响

注意：血淀粉酶↑可见于胰腺炎、胆石症、胆囊炎、消化性溃疡、消化道穿孔、肠梗阻、肠系膜缺血、腮腺炎、心肌梗死、巨淀粉酶血症